

Varicela

Norma H. Notti 2015

Introducción

La varicela es una enfermedad infecciosa provocada por el virus varicela – Zóster(VVZ)
Tasa de ataque secundario en huéspedes susceptibles: 90%

Modo de transmisión

- ✓ Contacto directo con lesiones vesiculares
- ✓ Vía aérea

Periodo de incubación: 10 y 21 días luego del contacto (y hasta 28 días en casos de contactos que recibieron gammaglobulina)

Periodo de contagio: 2 días antes de la erupción y hasta que todas las lesiones se encuentren en periodo de costra

Clínica:

La infección primaria por varicela se presenta por un exantema generalizado y pruriginoso que pasa de mácula a pápula, luego a vesícula y pústula y finaliza en costra, caracterizado por polimorfismo regional.

En pacientes inmunocomprometidos puede presentarse como varicela hemorrágica.

El zoster (culebrilla) es causado por la reactivación del VVZ desde donde permanece inactivo o latente en los ganglios de la raíces dorsales; luego de haberse producido la primo infección habitualmente durante la niñez, siendo más frecuente en la adultez.

Diagnóstico:

El diagnóstico es principalmente clínico.

La técnica más útil es la inmunofluorescencia para detectar el antígeno de muestras obtenidas de raspado o legrado de las lesiones.

La PCR es la técnica más sensible.

La detección de Ig M es menos fiable, y el cultivo viral y la elevación de Ig G proporcionar resultados tardíos

Complicaciones:

- ✓ Sobreinfección bacteriana de la piel y tejido celular subcutáneo: celulitis , adenitis abscedada ,estafilodermia, estafilococcemia-Síndrome de shock tóxico- (S β HA – SA)
- ✓ Neurológicas: encefalitis, meningitis aséptica, ataxia cerebelosa, síndrome de Guillain – Barré, mielitis transversa
- ✓ Respiratorias: neumonitis por varicela, neumonías bacterianas
- ✓ Gastrointestinales: hepatitis, gastroenteritis
- ✓ Osteoarticulares: artritis reactivas, osteomielitis, sinovitis
- ✓ Otras: hemorragias, púrpura, síndrome de Reyé, miocarditis, glomerulonefritis

Criterios de internación y hemocultivo en huésped inmunocompetente

Deberá correlacionarse siempre con el compromiso clínico del paciente

- ✓ Celulitis, Estafilodermia-estreptodermia- Síndrome de shock tóxico- (S β HA – SA)
- ✓ Sepsis
- ✓ Encefalitis
- ✓ Neumonitis con desaturación/ neumonía bacteriana
- ✓ Siempre debe internarse en huéspedes inmunocomprometidos

Tratamiento

La decisión de administrar antivirales, la vía y la duración del tratamiento dependen de factores específicos del huésped, la magnitud y la extensión de la infección.

- Varicela en huésped inmunocompetente

No se recomienda el uso de aciclovir (VO o EV) en niños inmunocompetentes

Podría considerarse tratamiento en:

- ✓ Niños sanos mayores de 12 /15 años (mayor riesgo de varicela de moderada a grave)
- ✓ Pacientes con trastornos cutáneos o pulmonares crónicos que reciben tratamiento con salicilatos
- ✓ Pacientes que reciben ciclos cortos e intermitentes en aerosol con corticoides
- ✓ Pacientes a partir del tercer o cuarto contacto
- ✓ Mujeres embarazadas segundo o tercer trimestre (categoría B)

Aciclovir VO

Dosis: 80 mg/kg/día c/6 hs

Dosis máxima: 3200 mg/día

Duración: 5 días

- Varicela en huésped inmunocomprometido

En este grupo de pacientes la enfermedad puede tener un comportamiento más agresivo por lo que el tratamiento debe ser endovenoso.

- ✓ Pacientes con patología hemato-oncológicas/ neoplasias
- ✓ Inmunosuprimidos
- ✓ Colágenopatía
- ✓ Inmunodeficiencias primarias y secundarias
- ✓ Infección por HIV

ACICLOVIR EV

Dosis: En < de 1 año 30mg/kg/día c/ 8 hs

En > de 1 año 1500mg/m² /día c/ 8 hs

Duración: 7 a 14 días (hasta que todas las lesiones estén en costra)

- Herpes Zoster en huésped inmunocompetentes

NO SE RECOMIENDA EL USO DE ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE ZOSTER EN NIÑOS INMUNOCOMPETENTES

Zoster oftálmico puede predisponer a la ceguera a cualquier edad ; sin tratamiento antiviral el 50% puede padecer complicaciones oculares graves; por lo cual requiere siempre tratamiento endovenoso.

- Herpes Zoster en huésped inmunocomprometidos

Se recomienda el tratamiento de Zoster en inmunocomprometidos y niños **inmunocompetentes con compromiso ocular**

ACICLOVIR EV

Dosis: En < de 1 año 30mg/kg/día c/ 8 hs

En > de 1 año 1500mg/m² /día c/ 8 hs

Duración: 7 a 14 días (hasta que todas las lesiones estén en costra)

En Zoster ocular podría extenderse a 4 – 6 semanas en algunos pacientes (principalmente inmuno comprometidos)

Podría considerarse el uso de tratamiento vía oral en pacientes con HIV (estadio A/categorización)

Varicela complicada

Celulitis no complicada: HMC + Clindamicina EV

Erisipela: HMC + Clindamicina + Penicilina

Sospecha de enfermedad invasiva: HMC + Clindamicina + Penicilina (gérmenes a cubrir: Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes)

Profilaxis Post-Exposición

¿Qué se considera *evidencia de inmunidad* contra varicela?

- Documentación de vacunación adecuada:
 - Niños entre 1 y 4-6 años (pre-escolares): 1 dosis
 - Niños en edad escolar, adolescentes y adultos: 2 dosis, con un intervalo mínimo de 3 meses en ≤ 12 años y de 4 semanas en ≥ 13 años.
- Evidencia serológica de infección pasada (IgG positiva)
- Antecedente de haber padecido varicela y/o herpes zoster. Diagnóstico realizado por personal de salud.
- Excepción: pacientes con trasplante de células hematopoyéticas a quienes, aunque hayan tenido la enfermedad o la inmunización adecuada antes del trasplante, se los considera no inmunizados

¿Qué se define como exposición a la varicela?

- Contactos convivientes
 - La varicela se presenta en aproximadamente 85% de los contactos susceptibles.
- Contacto estrecho
 - Pacientes en contacto cercano por más de una hora.
- Hospital:
 - Contacto cercano con enfermos con varicela, con herpes zoster diseminado o inmunocomprometidos con herpes zoster localizado.
 - Estos enfermos pueden ser: pacientes, familiares de los mismos o personal de salud.
 - **El contacto cercano hace referencia a la convivencia por más de 1 hora en la misma habitación o, en caso de habitaciones comunitarias, a todos los contactos.**

Vacuna

Una dosis administrada dentro de los 3 a 5 días del contacto es efectiva en prevenir la enfermedad (70-90%) o modificar su gravedad (100%).

La vacunación debería ser el método de elección para prevenir la varicela en instituciones hospitalarias.

Gammaglobulina

Se debería usar Gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) para los pacientes expuestos que tuvieran contraindicación para la vacunación y corrieran alto riesgo de complicaciones.

Indicaciones:

1) Pacientes inmunocomprometidos:

- Con inmunodeficiencias primarias y adquiridas
- Neoplasias
- Que reciben tratamiento inmunosupresor

2) Neonatos con indicaciones específicas:

- Neonatos de madres con varicela periparto (que empiezan con la enfermedad entre cinco días antes y dos días después del parto):
 - No es necesario, si la madre inició los síntomas antes de los cinco días.
 - No existe evidencia de que niños nacidos de madres que tienen varicela luego de las 48 horas del parto tienen mayor riesgo de complicaciones.
 - La IGVZ no estaría recomendada para recién nacidos de término, sanos, expuestos postnatalmente, incluso si la madre no tuvo varicela.
- Exposición intrahospitalaria en UCIN:
 - Indicaciones de IGVZ en UCIN:
 - RN PreT > 28 semanas, sin antecedentes de varicela materna.
 - RNPreT $\leq$ 28 semanas o < 1000 g al nacer: administrar gammaglobulina independientemente del estado inmunitario materno.

3) Mujeres embarazadas

La IGVZ está recomendada para embarazadas expuestas sin evidencia de inmunidad. En este grupo la IGVZ no previene la viremia, la infección fetal, el síndrome varicela congénita o varicela neonatal. Se les indica para prevenir las complicaciones en ellas mismas.

Posología

Una dosis dentro de las 96 horas y hasta los 10 días post exposición.

Duración de la protección: 3 semanas.

La administración de IGVZ podría extender el período de incubación de la enfermedad a más de 28 días.

IGVZ Intramuscular

- ✓ Dosis: 125 UI por c /10 kg
- ✓ Dosis máxima: 625 UI

Alternativas

- ✓ IGVZ EV: Dosis: 1 ml/kg en goteo lento.
- ✓ IGIV de pool (endovenosa): Dosis: 400 mg/kg.
 - Los pacientes que reciben IGIV mensualmente de manera regular están protegidos, si la última dosis les hubiera sido administrada hasta tres semanas previas a la exposición.

Intervalo adecuado entre la administración de la IGZ y la vacunación contra varicela

Si el paciente no desarrolla varicela debe colocarse la vacuna, luego de **cinco meses** tras la administración de IGZ, si no hubiera contraindicaciones para la misma.

Quimioprofilaxis

Si no se pudiera realizar control de brote de varicela con vacuna o gammaglobulina podría realizarse profilaxis con **aciclovir**, siendo esta una opción discutida ya que su uso podría influir en la respuesta inmune del paciente.

- Comenzando 5- 7 días luego de la exposición.
- 80 mg/kg/día, c/6 hs 7 días , VO
- Dosis máxima: 3200 mg/día

Medidas de aislamiento de los pacientes internados con varicela o contactos de varicela

- ✓ Alta precoz de los pacientes
- ✓ aislamiento aéreo desde el día 10 al 21(hasta 28 días si recibieron gammaglobulina)a partir de la exposición con el caso índice.
- ✓ Los pacientes internados con varicela deben permanecer internados en aislamiento respiratorio estricto durante todo el periodo vesiculoso.

Ficha de estudio brote de varicela en pacientes/familiares susceptibles

Nombre	HC	Fecha de comienzo del contacto	Fecha comienzo exantema caso índice	Edad	Factores de riesgo	Modalidad de manejo

Pacientes/ familiares contactos varicela no susceptibles:

Personal de salud:

Ficha manejo brote varicela en neonatología

Nombre	Fecha de comienzo del contacto	Fecha comienzo exantema caso índice	DDV	Peso Nacimiento	EG	Antec. Inmunitario materno	IGZ

Madres neonatología:

Personal de salud:

Bibliografía

- 1) *Recomendaciones sobre control de la varicela para equipos de salud*. Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2011.
- 2) Mona Marin, MD et al, *Prevention of Varicella: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)*, CDC, 2007.
- 3) Dra. Alejandra Gaiano et Al, *Vacunación en Huéspedes Especiales: Lineamientos Técnicos*, Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2013
- 4) Pickering et al, *Red book: Enfermedades infecciosas en Pediatría*, 27ª edición, Editorial Médica Panamericana, 2009.
- 5) FDA approval of an extended period for administering VarIZIG for postexposure prophylaxis of varicella. Centers for Disease Control and Prevention. CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Mar 30;61(12):2012).
- 6) En casos (excepcionalmente), se podría prolongar la utilización de la IGZ hasta los 10 días posteriores al contacto con el caso índice (FDA approval of an extended period for administering VarIZIG for postexposure prophylaxis of varicella. Centers for Disease Control and Prevention. CDC). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Mar 30;61(12):2012).